

# Cuando cae el diagnóstico y no la enfermedad

Una ruptura que ningún control de calidad podía detectar

**Daniel A. Garavito Jiménez**

Economista de la salud. Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE), trece rondas 2012–2025.

Entre 2022 y 2023, la prevalencia de enfermedad crónica diagnosticada que reporta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida cayó del 16,0 % al 11,9 %. Cuatro puntos en un año. Y se quedó ahí: 11,4 % en 2024, 11,0 % en 2025.

Una caída de esa magnitud en un indicador de morbilidad crónica sería una noticia extraordinaria. Cuatro puntos porcentuales de la población colombiana son alrededor de dos millones de personas que, de un año a otro, dejaron de tener un diagnóstico.

No pasó. Y lo que sí pasó vale la pena contarlo, porque es un modo de falla que le puede ocurrir a cualquiera que use estadísticas oficiales.

## La primera hipótesis, que también era falsa

Cuando vi la caída, mi primera lectura fue la que probablemente haría cualquier persona que conozca el sistema: en un país donde el acceso a la atención se estaba deteriorando, menos enfermedad crónica diagnosticada casi seguro significa **menos diagnóstico, no menos enfermedad**. Se diagnostica a quien llega a que lo diagnostiquen, y si llegar cuesta más, se diagnostica menos.

Lo anoté así, con esas palabras, en un documento de agenda de investigación en agosto de 2026. Era una hipótesis razonable, prudente y verificable.

También era equivocada.

## Lo que realmente cambió

En 2023, el DANE reformuló la pregunta. Hasta 2022 el cuestionario decía:

«¿Le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?»

Desde 2023 dice:

«En los últimos 12 meses, ¿le han diagnosticado alguna enfermedad crónica?»

Son ocho palabras de diferencia y cambian el indicador por completo. La primera versión mide **prevalencia**: cuánta gente carga hoy un diagnóstico, sin importar cuándo se lo hicieron. La segunda mide **incidencia a doce meses**: a cuánta gente se lo hicieron el año pasado.

Un hipertenso diagnosticado en 2015 responde «sí» a la primera pregunta y «no» a la segunda. Sigue siendo hipertenso. Sigue tomando el medicamento. Simplemente dejó de contar.

La subpregunta de tratamiento cambió en el mismo sentido y en la misma ronda: de «¿recibe o recibió tratamiento formulado por el médico?» a «¿actualmente está recibiendo tratamiento para esa enfermedad?».

## Por qué ningún control de calidad iba a encontrarlo

Y aquí está el punto que hace de esto algo más que una anécdota.

El nombre de la variable no cambió: sigue siendo P1930. Los códigos de respuesta no cambiaron: sigue siendo 1 para sí, 2 para no. Los rangos son válidos. La tasa de no respuesta no se movió. Los totales cuadran. La serie es internamente consistente de principio a fin.

**Ninguna validación contra el microdato podía detectarlo.** Todos los controles automáticos que uno corre sobre una serie —consistencia interna, validación de rangos, cuadro de totales, detección de valores atípicos— pasan sin levantar una sola alerta. La única huella del cambio está en el texto del cuestionario.

Se encontró leyendo el Historial de Cambios al Formulario que el DANE publica, y contrastando la descripción de la variable entre el diccionario de datos de 2021 y el de 2025. Fue lectura de documentación, no análisis de datos.

## La prueba de que es un escalón y no una tendencia

Conviene ser riguroso y no quedarse en la coincidencia de fechas. La forma de probar que se trata de un cambio de instrumento y no de un fenómeno es preguntarle a los datos si el movimiento tiene forma de **pendiente** —un proceso gradual— o de **escalón** —un salto de una sola vez.

Se ajusta a las seis rondas utilizables del diseño muestral vigente, dejando fuera los dos años de pandemia, un modelo que permite las dos cosas al tiempo: una tendencia anual y un salto en 2023. El resultado apunta en una sola dirección.

Tendencia: +0,14 puntos porcentuales por año. No se distingue de cero.

Escalón en 2023: -4,66 puntos porcentuales. Sí se distingue.

El modelo con escalón explica el 92 % de la varianza de la serie.

Todo el «descenso» ocurre en una ronda. A ambos lados de esa ronda no hay ninguna tendencia. Y hay que decir en voz alta lo que esa regresión no es: son seis observaciones anuales y tres grados de libertad. Si uno deja fuera un año a la vez, de las seis regresiones que resultan solo una conserva un escalón que se distinga de cero al 5 %, aunque la magnitud estimada se mantiene estable en todas. Un lector adversarial tiene razón si dice que la regresión, sola, no prueba nada.

La respuesta no es defender la regresión: es señalar que la regresión no es el argumento. El argumento es que la causa del quiebre es **exógena y está documentada**. El DANE reformuló la pregunta y lo dejó consignado en el historial de cambios al formulario. No estamos ante una discontinuidad descubierta en los datos y explicada después —que es el caso en que la fragilidad estadística sería fatal— sino ante un cambio de instrumento conocido de antemano cuyo efecto se cuantifica. La regresión no descubre la ruptura: mide la que el propio productor del dato declaró.

Ahora la parte que más me interesa. Si uno ajusta en cambio una sola recta a través de la ruptura —que es lo que haría cualquier analista cuidadoso pero desinformado— obtiene una caída sostenida de 0,64 puntos porcentuales por año con un  $R^2$  de 0,59. Es un resultado publicable, de aspecto sólido, y completamente falso.

Lo sé porque lo publiqué. Una versión anterior del tablero que acompaña a esta serie traía esa tendencia con un valor p por debajo de 0,05 y la interpretaba como un fenómeno del sistema de salud. Era enteramente el cambio de cuestionario.

## Dos contrastes que descartan las explicaciones sustantivas

Un buen diagnóstico no se sostiene solo con la evidencia a favor; se sostiene descartando las alternativas. Hay dos que valía la pena mirar.

**Si hubiera caído la enfermedad, la salud autopercebida habría mejorado.** No lo hizo. La proporción de personas que califica su estado de salud como regular o malo *aumentó* entre 2022 y 2023, de 12,5 % a 13,1 %. Una caída del 25 % en la prevalencia de enfermedad crónica en un solo año, si fuera real, debería haber empujado ese indicador en la dirección contraria. La salud autopercebida no es un control perfecto —también responde a expectativas y a la coyuntura—, pero es un control disponible y apunta en contra.

**Si hubiera caído el diagnóstico por deterioro del acceso, la composición de los diagnosticados habría cambiado.** La proporción de personas con enfermedad crónica que recibe tratamiento formulado se mantuvo idéntica: 89,5 % en 2022 y 89,4 % en 2023. Si el sistema hubiera dejado de diagnosticar por falta de acceso, cabría esperar que el subconjunto que sí llega a diagnóstico estuviera más seleccionado y se comportara distinto. No hay ninguna huella de eso.

## Tres clases de ruptura, y por qué esta es la peligrosa

La literatura de comparabilidad de series estadísticas distingue tres tipos de discontinuidad, y la diferencia entre ellas es práctica.

La **ruptura de marco** cambia la muestra, el universo o el ponderador. Es visible, suele venir anunciada y las oficinas estadísticas publican advertencias. Esta misma encuesta tiene dos ejemplos, y el DANE los documentó bien: el rediseño muestral de 2018, que llevó la muestra de 22.893 a 89.522 hogares y amplió el universo a zonas rurales que antes no se encuestaban, y el retiro oficial de la ronda de 2017.

La **ruptura de codificación** cambia las categorías de respuesta o su numeración. También es detectable, porque aparecen o desaparecen códigos en el archivo. La encuesta tiene una en 2014, cuando la pregunta por la razón de no consulta pasó de nueve a trece opciones.

Y está la **ruptura de universo**: cambia lo que la pregunta pide sin que cambie nada de lo que el archivo de datos contiene. Es la de 2023. Atraviesa sin resistencia todos los controles automáticos y llega intacta a la regresión.

De ahí se sigue una regla de trabajo que hoy me parece innegociable: **ninguna serie temporal de una encuesta está verificada si la verificación se hizo únicamente contra el microdato.** El cuestionario, el

manual del encuestador y el historial de cambios son fuente primaria de la misma jerarquía que los datos, y hay que leerlos año por año.

## Qué se puede y qué no se puede hacer con esta variable

**No se puede** trazar una serie de prevalencia de enfermedad crónica de 2018 a 2025. No se puede estimar una tendencia que cruce 2023. No se puede comparar el nivel de 2025 con el de 2019 ni con el nivel prepandémico. Cualquier resultado que dependa de esa comparación mide el cuestionario.

**Sí se puede** trabajar dentro de cada tramo. De 2018 a 2022 la variable mide prevalencia acumulada y es comparable consigo misma; de 2023 en adelante mide incidencia a doce meses y también lo es. Y sí se puede usar en corte transversal para cualquier año individual, que es donde está la mayor parte de su valor: desagregada por territorio, ingreso y régimen, la incidencia de diagnóstico en doce meses es un indicador legítimo de captación del sistema.

Conviene además ser justo con el cambio en sí. Las dos definiciones no son una peor que la otra: la vieja mide carga de enfermedad diagnosticada, la nueva mide actividad diagnóstica reciente, y para evaluar un sistema de salud la segunda es probablemente más útil. **El problema no es que el DANE haya cambiado la pregunta. Es que la variable siguió llamándose igual.**

## Tres cosas que se siguen de aquí

1. **Para el DANE:** la ruptura está documentada en el Historial de Cambios al Formulario, que es público y meritorio, pero no aparece como advertencia de comparabilidad junto a la serie, como sí ocurrió —con detalle y oportunidad— para 2017 y 2018. La solución mínima cuesta una línea: una nota de ruptura en la ficha de la variable. La solución correcta cuesta un poco más: renombrar la variable cuando cambia su universo, de modo que el propio archivo delate la discontinuidad. Es lo que hace Eurostat cuando un país declara *break in series*.
2. **Para quien use la encuesta:** descargar el cuestionario, el diccionario y el historial de cambios de cada ronda, y contrastar automáticamente la descripción de cada variable entre años consecutivos. Es barato comparado con el costo de publicar una tendencia que no existe.
3. **Para el debate:** hay una cifra que retirar. Cualquier afirmación de que la enfermedad crónica diagnosticada en Colombia cayó entre 2022 y 2025 —y la hay, en material de divulgación y en presentaciones— no se sostiene. La afirmación defendible es que el instrumento cambió de universo y que la serie no es comparable a través de esa fecha.

## Lo que este texto no prueba

La evidencia es documental y estadística, no experimental. No existe una ronda en la que se hayan aplicado las dos formulaciones en paralelo, así que **no es posible estimar cuánto de los 4,66 puntos del escalón corresponde al cambio de ventana temporal y cuánto podría deberse a otra causa.**

Lo que sí queda demostrado es que el cambio tiene forma de escalón y no de pendiente, que coincide exactamente con la ronda en que cambió el texto de la pregunta, y que dos contrastes independientes apuntan en contra de las explicaciones alternativas.

Un experimento sencillo lo resolvería: aplicar las dos formulaciones a submuestras distintas en una ronda futura. Con eso se obtendría el factor de empalme y la serie completa volvería a ser utilizable. Es una recomendación concreta y de costo acotado.

## El cierre

Fui asesor en la ADRES hasta agosto de 2026 y hoy escribo desde fuera del sistema, pero hay que decir algo con nombre propio, porque el rigor empieza en casa: la tendencia falsa la publiqué yo, en un tablero propio, y la corregí solo cuando fui a leer un documento que llevaba tres años disponible en la página del DANE.

El sistema de información en salud colombiano tiene un problema conocido: buena parte de sus datos los reporta quien tiene interés financiero en lo que reporta. Las encuestas de hogares son el contrapeso, y son un buen contrapeso. Pero tienen su propio modo de falla, y este es: **el dato puede estar impecable y la serie estar rota**.

Un instrumento que cambia sin avisar no miente. Simplemente deja de responder la pregunta que uno cree que le está haciendo.

## Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). *Historial de cambios al formulario, Encuesta Nacional de Calidad de Vida*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021 y 2025). *Diccionario de datos, ENCV — capítulo de Salud*. Bogotá: DANE.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Anexo técnico ECV 2017: comparabilidad de las cifras*. Bogotá: DANE.

Eurostat. (2020). *Handbook on quality reporting: breaks in series and their documentation*. Luxemburgo.

Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2.<sup>a</sup> ed.). Hoboken: Wiley.

Schwarz, N. (1999). Self-reports: how the questions shape the answers. *American Psychologist*, 54(2), 93-105.

Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). *The psychology of survey response*. Cambridge: Cambridge University Press.

## Descargo de responsabilidad

Las opiniones, análisis y reflexiones que publico en este espacio son exclusivamente de mi autoría y de carácter personal. Fui Asesor de Innovación y Analítica de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta agosto de 2026; a la fecha de esta publicación no me desempeño en el sector público ni en ninguna entidad del sistema de salud. Nada de lo aquí escrito constituye posición institucional ni representa el criterio oficial de la ADRES, del Ministerio de Salud y Protección Social, ni de ninguna otra entidad del sector.

Los contenidos se elaboran a partir de (i) información de dominio público —en particular los microdatos anonimizados que el DANE publica—, (ii) literatura académica verificable debidamente citada, y (iii) experiencia profesional acumulada a lo largo de

mi trayectoria. En ningún caso divulgan información reservada, datos personales de beneficiarios, datos de operación contractual, ni elementos bajo deber de confidencialidad institucional.

Cuando discuto mecanismos de política pública, metodologías técnicas o desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo hago en mi calidad de ciudadano y profesional del sector, con el ánimo de aportar al debate público informado. Las propuestas que formulo son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Quien desee la posición oficial de la ADRES sobre cualquier tema puede consultar sus canales institucionales en [www.adres.gov.co](http://www.adres.gov.co).

El procesamiento que sustenta las cifras de esta columna es reproducible y está documentado en el documento de trabajo correspondiente de la serie. Esta versión es un borrador sometido a revisión externa: se agradece cualquier corrección.

Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.